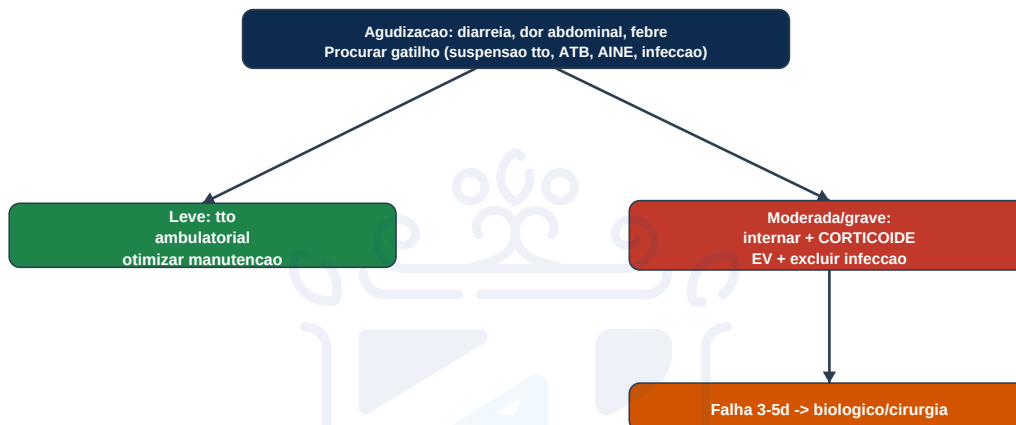


DOENÇA DE CROHN — EMERGÊNCIA E AGUDIZAÇÃO

FLUXOGRAMA — AGUDIZAÇÃO

CROHN — GRAVIDADE GUIA A INTERNAÇÃO



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Doença inflamatória intestinal crônica, imunomediada, com inflamação TRANSMURAL
- Pode acometer qualquer segmento da boca ao ânus (descontínua, 'salteada')
- Cursa com agudizações e complicações inflamatórias, estenosantes e fistulizantes
- Gatilhos de agudização: suspensão/uso irregular da manutenção, infecção (*C. difficile*, CMV), AINE, progressão

CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE (SBG)

Gravidade	Crítérios clínicos	Laboratório/complicações
Leve	≤ 4 evacuações/dia, sem febre/dor intensa	Sem anemia significativa
Moderada	> 4 evacuações/dia, dor abdominal, febre baixa	Perda de peso $< 10\%$, anemia leve
Grave	≥ 6 evacuações/dia com sangue, febre > 38 , FC > 90	Hb < 10 , PCR/VHS altos, abscesso/megacólon/perfuração

RED FLAGS — MEGACÓLON TÓXICO

COMPLICAÇÃO POTENCIALMENTE FATAL

- Diâmetro colônico ≥ 6 cm no RX simples + febre, taquicardia, leucocitose + toxemia
- Distensão abdominal e parada de eliminação de gases
- Outras emergências: abscesso intra-abdominal, perfuração, hemorragia maciça, sepse
- Suspender via oral; corticoide EV; ATB amplo espectro; correção hidroeletrólítica; monitorização intensiva
- Cirurgia de emergência: perfuração, hemorragia maciça, choque séptico ou sem melhora em 48-72h

AVALIAÇÃO E EXAMES

NO PS

- Checklist: sinais de gravidade sistêmica, dor/defesa, sepse, distensão, parada de eliminação de gases
- Suspendar alimentação oral em casos moderados/graves
- Hemograma, PCR, VHS, função renal, eletrólitos, ALBUMINA
- Coprocultura + toxina para *C. difficile* (excluir infecção que mimetiza/precipita)
- TC de abdome com contraste (abscesso, perfuração, estenose); RX de abdome se suspeita de megacólon

TRATAMENTO DA AGUDIZAÇÃO

Rx CORTICOIDE (base, mod/grave)

Hidrocortisona 100mg EV 6-8/8h, OU
Metilprednisolona 60mg EV 1x/dia
Avaliar resposta em 72-96h
Contra (relativas): infecção ativa não tratada,
perfuração, megacólon sem controle
Profilaxia de TEV (HBPM); evitar
AINE/opioide/antidiarreico

Rx ATB (quando indicado)

Indicações: abscesso intra-abdominal, sepse, doença
perianal ativa
Ciprofloxacino 400mg EV 12/12h
+ Metronidazol 500mg EV 8/8h
ATB NÃO é tratamento da inflamação per se
Drenagem do abscesso conforme avaliação cirúrgica

FALHA AO CORTICOIDE

REFRATARIEDADE (3-5 DIAS)

- Ausência de resposta após 3-5 dias de corticoide EV = falha terapêutica
- Reavaliar diagnóstico e EXCLUIR infecção (*C. difficile*, CMV)
- Terapia de resgate: biológico (anti-TNF) conforme protocolo especializado
- Avaliar complicações mecânicas (estenose/fístula)
- Solicitar avaliação CIRÚRGICA precoce

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: doença moderada/grave, necessidade de corticoide EV, complicação inflamatória, megacólon, falha ambulatorial
- ☐ ALTA: resolução da dor e diarreia, sem sinais de complicação
- ☐ ALTA: terapia de manutenção definida + seguimento com gastroenterologia garantido
- ☐ Orientar adesão à manutenção e evitar AINE
- ☐ Retorno se: febre, dor intensa, sangramento, distensão, parada de eliminação de gases

MODELO DE ENCAMINHAMENTO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Doença de Crohn em agudização (gravidade SBG: ____). Evacuações/dia: ____; febre: sim/não; PCR: ____.
- Complicações: abscesso / megacólon / perfuração / fístula. TC de abdome: ____.
- Condutas: corticoide EV ____; ATB ____; profilaxia de TEV.
- Motivo da transferência: falha terapêutica / megacólon tóxico / avaliação cirúrgica.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com Crohn, 8 evacuações/dia com sangue, febre 38,5, FC 100, Hb 9, PCR elevada. Qual a conduta inicial?

- A) Alta com corticoide oral e retorno em 30 dias
- B) Internação + corticoide endovenoso + exclusão de infecção (C. difficile/CMV)
- C) Antidiarreico e observação
- D) Apenas hidratação oral
- E) Antibiótico oral isolado

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o critério radiológico de megacólon tóxico?

- A) Diâmetro colônico ≥ 6 cm em RX simples com toxemia
- B) Espessamento de parede < 3 mm
- C) Pneumoperitônio isolado
- D) Diâmetro colônico de 3 cm
- E) Presença de fezes no cólon

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Após 3-5 dias de corticoide EV sem melhora, o que caracteriza e qual a conduta?

- A) Cura — dar alta
- B) Refratariedade ao corticoide — excluir infecção, considerar biológico de resgate e avaliação cirúrgica
- C) Indicação de antidiarreico
- D) Aumentar a dieta oral
- E) Reduzir a dose do corticoide pela metade

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual exame deve ser solicitado para excluir infecção que precipita/mimetiza a agudização da DII?

- A) Amilase
- B) Coprocultura e toxina para Clostridioides difficile
- C) Lipase
- D) TSH
- E) Ácido úrico

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual classe de medicamento deve ser EVITADA por poder precipitar/agravar a agudização da doença de Crohn?

- A) Inibidores de bomba de prótons
- B) Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs)
- C) Antieméticos
- D) Corticoides
- E) Reposição de ferro

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Crohn grave (Truelove-equivalente SBG) é emergência clínica: interna-se para corticoide EV (hidrocortisona/metilprednisolona), sempre excluindo infecção associada (C. difficile/CMV) que pode precipitar e contraindica intensificar imunossupressão sem tratar.

QUESTÃO 2 → Resposta: A

Megacólon tóxico = dilatação colônica ≥ 6 cm em RX simples associada a febre, taquicardia, leucocitose e toxemia. É emergência com risco de perfuração, exigindo conduta intensiva e avaliação cirúrgica.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Ausência de melhora após 3-5 dias de corticoide EV define refratariedade: reavaliar diagnóstico, excluir infecção, indicar terapia de resgate (anti-TNF) e acionar avaliação cirúrgica precoce.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Coprocultura e toxina para C. difficile (e pesquisa de CMV em refratários) excluem infecções que mimetizam ou precipitam a agudização da DII — fundamental antes de intensificar a imunossupressão.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Os AINEs devem ser evitados na DII: precipitam e agravam agudizações. Também se evita opioides e antidiarreicos (risco de megacólon) na fase aguda grave.

SM24
Suporte ao Plantão Médico